

Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo · Documento DT-06
Borrador para comentarios. No citar sin contrastar.

El carnet y el servicio

Cobertura récord y prestación en deterioro: el balance de 2025 del sistema de salud colombiano desde la encuesta de hogares

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Ex asesor de Innovación y Analítica, ADRES.

Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE).

Septiembre de 2026

Versión 1.0 · 12 de septiembre de 2026 · Cítese la versión. Las correcciones posteriores a la publicación quedan con fecha en la fe de erratas: datos.sinergistica.com/erratas.html

Resumen

En 2025 la afiliación al SGSSS alcanzó 97,2%, su máximo histórico y +4,1 puntos porcentuales sobre el nivel prepandémico ($z = 21,79$), con una tendencia de +0,60 pp/año en el diseño vigente ($p = 0,0025$; $R^2 = 0,920$). Y es una cobertura equitativa: plana entre quintiles de ingreso y mayor en zona rural que en cabecera. En el mismo año, la entrega incompleta de medicamentos, la espera en urgencias y la barrera de trámite alcanzaron sus máximos del diseño vigente, con diferencias contra el nivel prepandémico que se distinguen de cero.

Este documento presenta el balance completo de los quince indicadores del proyecto contra el promedio de 2018–2019, único ancla comparable, y sostiene que la coexistencia de cobertura récord con prestación en deterioro no es una anomalía sino el resultado central del año: la restricción del sistema terminó de desplazarse del aseguramiento a la prestación, y los tres deterioros están precisamente donde el carnet debe convertirse en servicio.

Dos correcciones acompañan el balance. La caída de la percepción de calidad que destacó el boletín de 2025 (–2,9 pp frente a 2024) es real, pero contra el nivel prepandémico la percepción es indistinguible ($p = 0,8346$): lo que ocurrió es que subió +6,8 puntos en 2020, en plena pandemia, y está regresando. Y la mejora de la salud autopercebida, que sí es sostenida, convive con una brecha entre quintiles de 11,3 puntos que no se cierra.

Palabras clave

cobertura universal en salud; cobertura efectiva; Quintuple Meta; Ley Estatutaria 1751 de 2015; equidad; ENCV; SGSSS

1. Dos cosas ciertas a la vez

En 2025 la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud alcanzó su máximo histórico: **97,2%** de la población, +4,1 puntos porcentuales por encima del nivel prepandémico, con $z = 21,79$. En el mismo año, la proporción de personas con fórmula médica a quienes no les entregaron todo lo formulado llegó a **46,9%**, el máximo de trece rondas, y la espera de más de una hora en urgencias a **36,0%**, también el máximo. Las tres cifras salen de la misma encuesta, la misma muestra y el mismo cuestionario.

Este documento sostiene que esa coexistencia no es una anomalía a explicar sino **el resultado central del año**, y que ordena todo lo demás. El sistema colombiano resolvió el problema de la afiliación —lo resolvió de verdad, y de forma equitativa, que es lo más notable— y en el mismo movimiento dejó al descubierto que la afiliación no era el problema. Lo que el hogar reporta ahora no es que no tenga carnet: es que el carnet no le entrega el medicamento.

El balance de 2025 contra el nivel prepandémico. De los quince indicadores del proyecto, trece son comparables contra 2018–2019. De esos trece, cinco tienen una diferencia que se distingue de cero: tres son deterioros —medicamentos, espera en urgencias y barrera de trámite— y dos son mejoras —afiliación y salud autopercebida—. En los ocho restantes la diferencia no se distingue de cero, lo que no significa que no hayan cambiado sino que estos datos no permiten afirmarlo. Los dos indicadores del módulo de crónicos quedan aparte por una ruptura de cuestionario documentada en el documento DT-04 de esta serie.

2. Marco: cobertura nominal y cobertura efectiva

La distinción entre estar cubierto y ser atendido es el eje de la agenda global de cobertura universal en salud de la última década. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial la formulan como la diferencia entre *service coverage* y *effective coverage*: la primera cuenta a quien tiene derecho al servicio; la segunda, a quien obtiene de él el beneficio sanitario esperado. Un sistema puede maximizar la primera y estancar la segunda, y los indicadores de afiliación —que son los más fáciles de producir y los más citados— no distinguen entre ambos casos.

Colombia es un caso de manual. La Ley 100 de 1993 organizó el sistema alrededor del aseguramiento y la Ley 1438 de 2011 fijó la universalidad como principio; el país persiguió esa meta durante tres décadas y la alcanzó. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 desplazó el eje: definió la salud como derecho fundamental y enumeró sus elementos esenciales —disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad—, ninguno de los cuales se satisface con la afiliación. Su artículo 7 ordena al Ministerio publicar una evaluación anual de los indicadores de goce efectivo del derecho. Diez años después, el indicador que el debate público sigue citando es el de afiliación.

El marco de la Quíntuple Meta —salud poblacional, experiencia de atención, costo per cápita, bienestar del equipo de salud y equidad— aporta la otra mitad del andamiaje. Una encuesta de hogares puede medir cuatro de sus cinco dimensiones; el bienestar del equipo de salud queda fuera por construcción y este proyecto lo declara como vacío en lugar de sustituirlo por un indicador de conveniencia. Lo que la organización por metas hace visible es que los tres deterioros de 2025 pertenecen todos a la experiencia de atención, y que las dos mejoras pertenecen a dimensiones distintas: una al aseguramiento y otra a la salud poblacional.

3. Datos y método

Trece rondas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida entre 2012 y 2025, procesadas desde el microdato anonimizado del DANE. Se excluye la ronda de 2017, retirada oficialmente por el DANE. La serie se presenta partida en el rediseño muestral de 2018 y ninguna tendencia cruza esa fecha. Los errores estándar se estiman por linealización de Taylor con las variables de diseño disponibles en el microdato de 2022, 2024 y 2025 y una corrección declarada por indicador en los años restantes; los intervalos de confianza son logit (Korn y Graubard, 1998).

El ancla de comparación es el promedio de 2018 y 2019: los dos únicos años prepandémicos que comparten el diseño muestral vigente, y la misma convención que usa el DANE al referirse a «2019, año previo a la pandemia». La elección del ancla es la decisión que más cambia las conclusiones de este tipo de ejercicio. Comparar 2025 contra 2023 —el piso al que bajó el sistema— convierte una recuperación parcial en un desplome; comparar contra 2012 cruza dos encuestas distintas.

La afiliación estimada por este procesamiento reproduce la publicada por el DANE en sus boletines en las trece rondas, dentro de $\pm 0,04$ puntos porcentuales. La percepción de calidad y la entrega de medicamentos de 2025 también coinciden con el boletín. Es la verificación externa del procesamiento.

4. Resultados

4.1 El balance completo

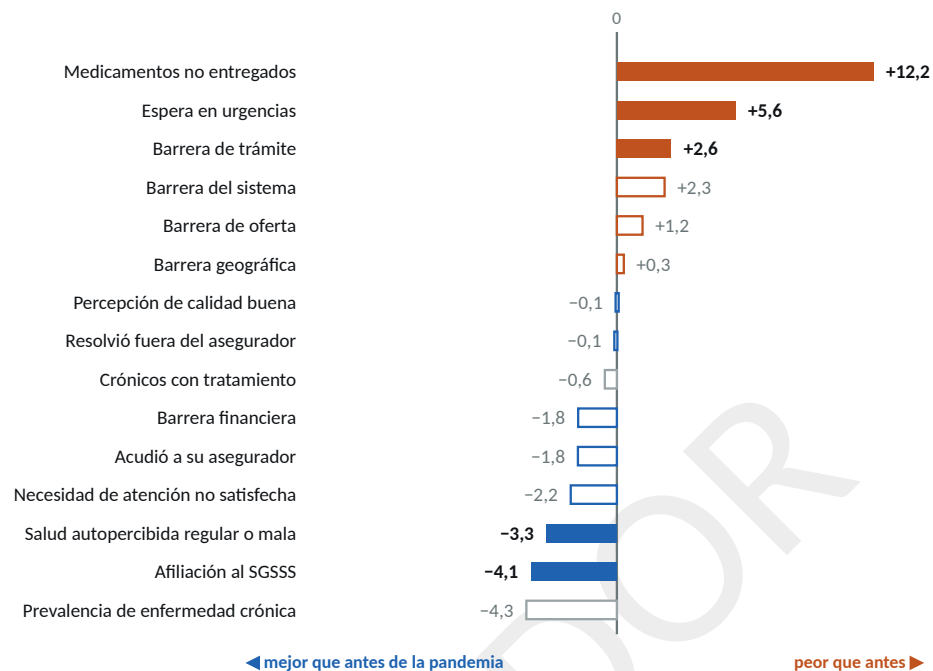


Figura 1. Diferencia de cada indicador en 2025 frente al nivel prepandémico (promedio 2018–2019), en puntos porcentuales, con el signo orientado: a la derecha significa peor para quien usa el sistema, aunque el número bruto haya bajado. Barra llena: la diferencia se distingue de cero al 5%. Barra hueca: no. Barra rayada y gris: serie no comparable con 2018–2019 por la ruptura de cuestionario de 2023 (véase DT-04). Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

Indicador	2025 (%)	2018-19 (%)	Dif. (pp)	EE	z	p	Holm	p con τ^2	Pend. (pp/año)	p
Afiliación al SGSSS	97,2	93,2	+4,1	0,19	21,79	< 0,0001	sí	0,0010	+0,60	0,0025
Salud autopercebida regular o mala	12,3	15,6	-3,3	0,22	-15,33	< 0,0001	sí	0,0024	-0,48	0,0245
Prevalencia de enfermedad crónica †	11,0	15,3	-4,3	0,22	-19,31	< 0,0001	—	—	—	—
Crónicos con tratamiento †	89,7	89,2	+0,6	0,46	1,25	0,2116	—	—	—	—
Necesidad de atención no satisfecha	35,9	38,1	-2,2	1,56	-1,40	0,1612	no	0,6281	-1,02	0,3546
Barrera del sistema	28,1	25,8	+2,3	2,08	1,09	0,2756	no	0,3828	+0,67	0,1683
Barrera de trámite	6,5	3,9	+2,6	1,18	2,16	0,0306	no	0,0597	+0,44	0,0049
Barrera geográfica	5,9	5,5	+0,3	0,67	0,49	0,6225	no	0,6940	-0,13	0,4334
Barrera financiera	3,9	5,8	-1,8	1,11	-1,66	0,0975	no	0,0975	-0,17	0,4073
Barrera de oferta	11,8	10,6	+1,2	1,62	0,75	0,4519	no	0,5857	+0,54	0,2389
Medicamentos no entregados	46,9	34,7	+12,2	1,80	6,74	< 0,0001	sí	0,0025	+0,91	0,3370
Espera en urgencias	36,0	30,4	+5,6	2,02	2,78	0,0054	no	0,0358	+0,38	0,4837
Percepción de calidad buena	81,9	81,8	+0,1	0,31	0,21	0,8346	no	0,9543	+0,25	0,3795
Resolvió fuera del asegurador	41,3	41,4	-0,1	1,46	-0,09	0,9304	no	0,9761	-0,81	0,4442
Acudió a su asegurador	56,8	54,9	+1,8	1,56	1,18	0,2381	no	0,6912	+1,07	0,3457

Cuadro 1. Los quince indicadores contra el nivel prepandémico y su tendencia en el tramo vigente (2018-2025, sin años de pandemia). Filas resaltadas: la diferencia contra el ancla se distingue de cero antes de corregir por multiplicidad. La columna **Holm** aplica el procedimiento de Holm-Bonferroni a la familia de los trece indicadores comparables: *sí* significa que la diferencia sobrevive a la corrección. La columna **p con τ^2** recalcula el mismo contraste añadiendo al error estándar la varianza de proceso entre rondas —la dispersión observada entre años que la varianza muestral no explica—, que es el supuesto más exigente y el más realista para una serie anual. † Serie con ruptura de universo en 2023; su diferencia contra 2018-2019 mide el cambio de cuestionario y no debe interpretarse, y por eso queda fuera de la familia de Holm. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

4.2 La afiliación, y por qué su equidad es el dato importante

La afiliación creció de forma sostenida a lo largo de todo el tramo vigente: +0,60 puntos porcentuales por año, con $t(4) = 6,77$, $p = 0,0025$ y $R^2 = 0,920$. Es, junto con la salud autopercebida y la barrera de trámite, uno de los tres únicos indicadores del proyecto con una tendencia que se distingue de cero, y el único de los tres cuya deriva es favorable.

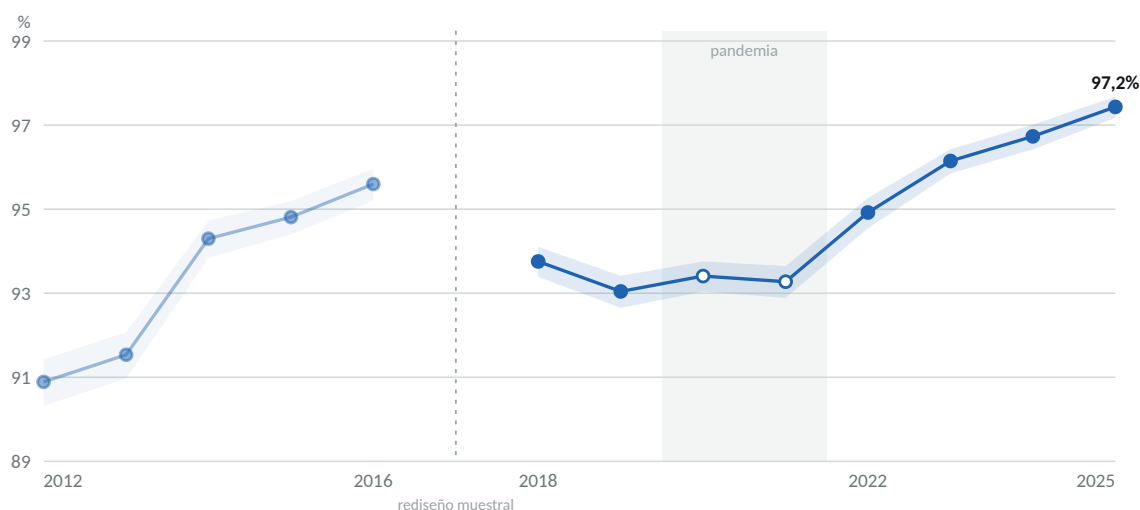


Figura 2. Afiliación al SGSSS, 2012–2025. La caída aparente entre 2016 y 2018 es un efecto del rediseño muestral, que amplió el universo a zonas rurales antes no encuestadas: los dos tramos no son comparables. Dentro del tramo vigente la serie crece de forma sostenida. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

El resultado que merece subrayarse no es el nivel sino su distribución, y aquí conviene aplicar el mismo rasero que este documento le exige a los indicadores adversos. En la escala de la afiliación la diferencia entre quintiles es pequeña —96,9% en el más pobre frente a 98,9% en el más rico, 2,0 puntos— pero *no* es cero: el contraste da $z = 3,34$, $p = 0,0008$. Y en la escala complementaria, que es la que importa para la política, la distancia se ve mejor: la no afiliación pasa de 1,1% en el quintil más rico a 3,1% en el más pobre, es decir 2,7 veces más. Decir «plana» sería exactamente el error que en DT-01 se le reprocha a la lectura ingenua del gradiente.

Dicho eso, la magnitud importa. Una brecha de 2,0 puntos sobre un nivel del 97,2% deja al quintil más pobre por encima de la cobertura poblacional de la mayoría de los países de la OCDE, y la afiliación es además **mayor en zona rural que en cabecera**: 97,7% frente a 97,1% ($p = 0,0209$). El departamento con menor afiliación, Arauca, está en 92,5%. La formulación defendible no es que no haya gradiente, sino que **el gradiente que queda es de un orden de magnitud distinto al de cualquier otro indicador de esta serie**. Es un logro real, es el resultado de treinta años de política deliberada, y ningún diagnóstico honesto del sistema debería omitirlo.

4.3 Los tres deterioros

Frente a eso, tres indicadores de la experiencia de atención están en su máximo del diseño vigente y sus diferencias contra el ancla se distinguen de cero. La entrega incompleta de medicamentos subió +12,2 puntos ($p < 0,0001$); la espera de más de una hora en urgencias, +5,6 puntos ($p = 0,0054$); la barrera de trámite, +2,6 puntos ($p = 0,0306$). Cada uno tiene su documento en esta serie —DT-01, DT-05 y DT-02 respectivamente— y cada uno resulta ser una cosa distinta: un escalón sin gradiente, un escalón con el gradiente invertido por selección, y una tendencia sostenida.

Ahora bien, los tres no aguantan lo mismo, y conviene decirlo antes de que lo diga otro. Sometidos a las dos exigencias adicionales del Cuadro 1 —la corrección de Holm por comparaciones múltiples y la incorporación de la varianza de proceso entre rondas— el resultado se ordena así: **solo la entrega de medicamentos sobrevive a ambas** (Holm: sí; p con $\tau^2 = 0,0025$). La espera en urgencias sobrevive a la segunda pero no a la primera (Holm: no; p con $\tau^2 = 0,0358$). La barrera de trámite no sobrevive a ninguna de las dos como diferencia de nivel (Holm: no; p con $\tau^2 = 0,0597$), aunque su fuerza probatoria no está en el escalón sino en la pendiente, que sí se distingue de cero. La lectura honesta del año, entonces, no es «tres deterioros»: es **un deterioro robusto, uno probable y una tendencia**. El resto de este documento usa esa jerarquía y no la anterior.

Conviene ser explícito sobre lo que *no* se deterioró, porque el diagnóstico pierde fuerza si exagera. La necesidad de atención no satisfecha no se distingue de su nivel prepandémico ($p = 0,1612$); la barrera financiera bajó, aunque tampoco de forma concluyente; la barrera geográfica y la de oferta están donde estaban. El deterioro de 2025 no es general: está localizado en tres puntos precisos de la cadena de atención, y los tres están del lado de lo que el sistema entrega, no de lo que el usuario puede pagar o alcanzar.

4.4 La percepción de calidad: una lección sobre las expectativas

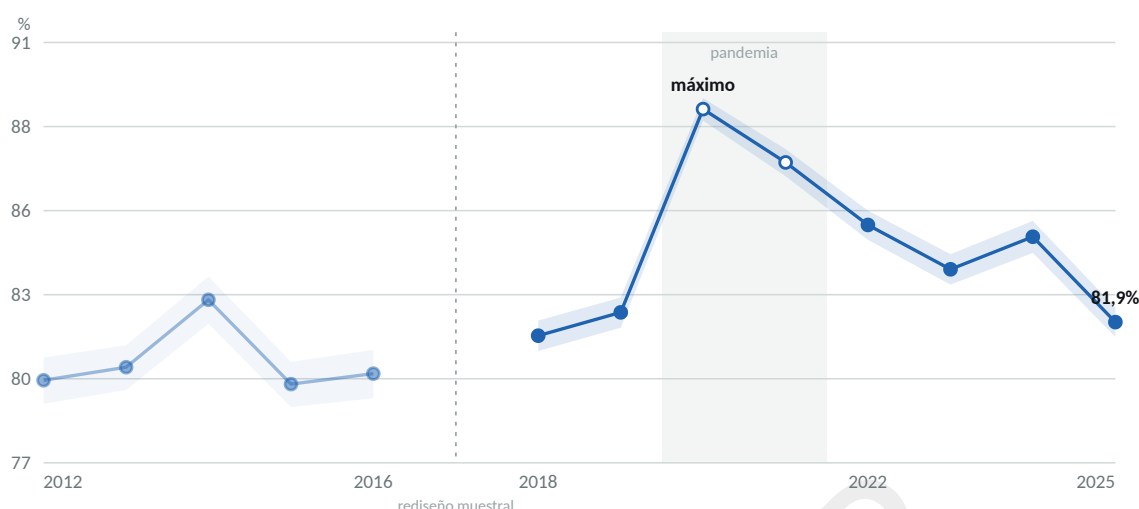


Figura 3. Percepción de calidad buena o muy buena del servicio de la EPS, 2012–2025. El máximo de la serie ocurre en 2020, en plena pandemia. La cifra incluye a quienes responden «no sabe» en el denominador, que es la convención del boletín del DANE y por la cual esta estimación coincide con la publicada. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

El boletín de la ECV 2025 destacó la caída de la percepción de calidad frente a 2024, y la caída es real: $-2,9$ puntos porcentuales, $z = -7,70$, $p < 0,0001$. Pero medida contra el nivel prepandémico, la percepción de calidad de 2025 —81,9%— es indistinguible de la de 2018–2019: $+0,1$ puntos, $p = 0,8346$. Lo que ocurrió no es que la percepción cayera por debajo de su norma: es que **subió durante la pandemia y está regresando**.

El salto de 2019 a 2020 fue de $+6,8$ puntos porcentuales ($z = 21,18$), el mayor movimiento interanual de todos los indicadores del proyecto. Ocurrió en el año en que la utilización de servicios se desplomó. La interpretación más económica es que la percepción de calidad es una comparación entre lo recibido y lo esperado, y que en 2020 lo esperado bajó más rápido que lo recibido. Es la misma adaptación de expectativas que sesga los indicadores de necesidad no satisfecha, operando aquí sobre una escala de satisfacción. La consecuencia práctica es que **la percepción de calidad no debe usarse como indicador de desempeño del sistema en un periodo de choque**: mide el desempeño relativo a una expectativa que el propio choque desplaza.

4.5 La salud autopercebida mejora, y eso también hay que explicarlo

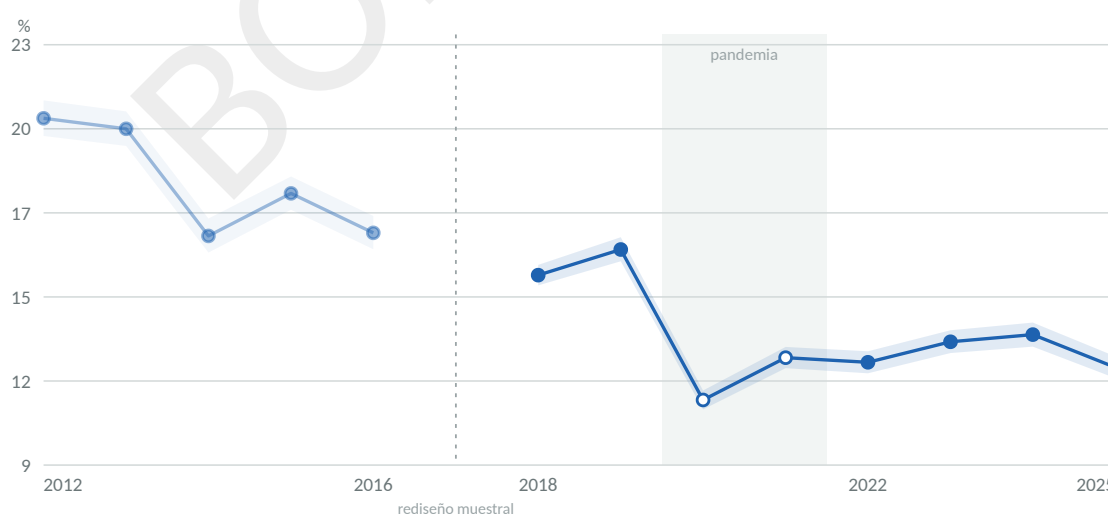


Figura 4. Personas que califican su estado de salud como regular o malo, 2012–2025. La recta continua es la regresión del tramo vigente sin años de pandemia: la pendiente se distingue de cero. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

El segundo indicador con mejora significativa es la salud autopercebida: el 12,3% califica su salud como regular o mala en 2025, $-3,3$ puntos por debajo del nivel prepandémico ($p < 0,0001$), con una tendencia descendente

sostenida de -0,48 puntos por año ($p = 0,0245$, $R^2 = 0,756$). La salud autopercebida es uno de los predictores más robustos de mortalidad y de uso de servicios que existe en la literatura epidemiológica, de modo que la mejora no es trivial.

Tres advertencias la acotan. La primera es que este indicador no está estandarizado por edad, y la estructura demográfica del país cambia. La segunda es que también responde a expectativas y al clima general, con el mismo mecanismo descrito para la percepción de calidad. La tercera, y la más relevante para el argumento de este documento, es que la salud autopercebida tiene un gradiente socioeconómico muy pronunciado que la mejora del promedio no cierra: en 2025 va de 22,2% en el quintil más pobre a 11,0% en el más rico —11,3 puntos, $p < 0,0001$ —. Que el promedio nacional mejore mientras esa distancia se mantiene es exactamente el patrón que la quinta meta —la equidad— fue añadida al marco para hacer visible.

5. Interpretación

La lectura que este documento propone es que **2025 marca el año en que la restricción del sistema colombiano terminó de desplazarse del aseguramiento a la prestación**, y que ese desplazamiento no es un fracaso de la política de cobertura sino su consecuencia. Mientras una fracción significativa de la población no tenía carnet, el indicador que importaba era el carnet. Universalizado el carnet, lo que queda expuesto es la capacidad del sistema para convertirlo en servicio, y esa capacidad se mide en el mostrador de la farmacia, en la ventanilla de autorización y en la sala de espera de urgencias. Es exactamente donde están los tres deterioros.

La ENCV no permite decir por qué. Son cortes transversales repetidos, no un panel: muestran cuándo cambia un nivel, nunca la causa. La coincidencia entre el deterioro de la entrega de medicamentos y la situación financiera del aseguramiento en 2024–2025 es una hipótesis a contrastar con fuentes administrativas, no un resultado de este trabajo. Lo que sí se sigue del dato es una restricción sobre las explicaciones admisibles: cualquier hipótesis que explique el deterioro por características del usuario —su pobreza, su ruralidad, su nivel educativo— es incompatible con el hallazgo del documento DT-01, según el cual la falla de entrega no tiene gradiente.

Hay una segunda lección, metodológica y transversal a toda la serie. Tres de los cinco resultados que este documento presenta como firmes solo lo son porque el error estándar se estimó sobre el diseño complejo de la encuesta, y dos de las conclusiones que circulan en el debate público —la recuperación del acceso general y la caída de la enfermedad crónica— no sobreviven al examen: la primera porque no se distingue de cero cuando la varianza se estima bien (DT-03), la segunda porque mide un cambio de cuestionario (DT-04). Un sistema de información que se audita a sí mismo necesita que el auditor publique también sus propias correcciones.

6. Referencia internacional: dónde está Colombia

De los indicadores de este balance, el de afiliación es el único con referente internacional plenamente comparable — y es el único donde a Colombia le va bien. La coincidencia no es casual y el documento DT-07 de esta serie la desarrolla.

Cobertura poblacional, según la OCDE. Colombia aparece con 98,9 % en 2023 —la nota de país de la propia organización la redondea a 99 %—, por encima de Estados Unidos (92,4 %), México (77,6 %), Costa Rica (93,0 %), Estonia (94,8 %), Eslovaquia (95,5 %), Hungría (96,0 %) y Polonia (96,9 %); y por debajo de los veintiún países de la organización que están en 100,0 %. Esa cifra proviene de registro administrativo. La de este trabajo —97,2 %— proviene de autorreporte en hogares. **No son la misma medición:** para un ranking OCDE corresponde la primera; la de la ENCV sirve para la serie histórica y para las desagregaciones por ingreso, territorio y pertenencia étnica, que el registro administrativo no permite construir con la misma riqueza.

Cobertura efectiva de servicios, según el ODS 3.8.1. Este indicador es un índice compuesto de catorce indicadores trazadores —salud reproductiva, enfermedades infecciosas, no transmisibles, capacidad y acceso— en escala de 0 a 100. *No mide afiliación.* Colombia obtiene **82** en 2023, frente a 79 de América Latina y el Caribe y 71 del promedio mundial.

Ese par de cifras es la formulación más económica de la tesis de este documento: **97,2 % de afiliación y 82 sobre 100 de cobertura efectiva de servicios**. Los tres deterioros de 2025 —medicamentos, urgencias y trámite— son precisamente la medición de la distancia entre las dos.

6.1 Y para los tres deterioros, no hay vara

Conviene cerrar el balance con lo que no se puede decir. No existe ningún estándar internacional de derechos humanos que fije un umbral numérico de cumplimiento para la entrega de medicamentos, el acceso a la atención o la oportunidad en urgencias. La Observación General 14 del Comité DESC —de la que provienen los cuatro elementos esenciales del artículo 6 de la Ley Estatutaria— establece que su aplicación precisa «dependerá

de las condiciones prevalecientes en cada Estado parte» e *invita a los Estados a fijar sus propias referencias*. El marco de derechos aporta el método, no la cifra.

Colombia tiene ese mandato desde 2015 en el artículo 7 de la misma ley, que ordena al Ministerio divulgar evaluaciones anuales del goce efectivo en función de los cuatro elementos. Los informes existen para 2021 a 2024. Ninguna resolución adopta la batería de indicadores, que las propias tablas declaran como «elaboración propia». Ninguno de los tres indicadores de medicamentos tiene meta. Y en septiembre de 2025 la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 calificó el cumplimiento como **bajo** y la falta de continuidad metodológica de la batería como un «**retroceso sustantivo**» respecto de lo ordenado diecisiete años antes. Conviene precisar el alcance de esa calificación, que suele citarse recortada: la Corte la predica de la orden trigésima en su conjunto —el deber de definir, medir y publicar indicadores de goce efectivo del derecho— y no de un indicador en particular.

De modo que el balance de 2025 termina con una asimetría que vale la pena nombrar: **la dimensión que Colombia resolvió es la que el mundo sabe medir; las que no ha resuelto son las que ni el mundo ni Colombia han decidido cómo calificar.**

7. Límites

Autorreporte en todo. Cada indicador de este documento es lo que el hogar declara. La afiliación autorreportada puede diferir de la afiliación efectiva en la base de datos única; la percepción de calidad y la salud autopercibida responden a expectativas; la entrega de medicamentos depende de la recordación. La independencia respecto del regulado es la virtud de la fuente; la subjetividad es su costo.

Sin causalidad. Ninguna afirmación de este documento es causal, y ninguna coincidencia temporal entre una medida de política y un quiebre de la serie debe leerse como efecto.

Potencia limitada. Los ocho indicadores cuya diferencia no se distingue de cero no son indicadores estables: son indicadores sobre los que estos datos no permiten concluir. Con seis rondas anuales y efectos de diseño entre 1,1 y 17,3, la encuesta detecta escalones grandes y es ciega a cambios moderados.

Una meta que no se puede medir. El bienestar del equipo de salud —la cuarta meta— no tiene ninguna variable en una encuesta de hogares. Se declara como vacío.

8. Implicaciones de política

Primero: cambiar el indicador de titular. Mientras la afiliación sea la cifra que abre el boletín y el debate, el sistema seguirá siendo evaluado por la dimensión que ya resolvió. La sustitución natural es un pequeño conjunto de indicadores de prestación efectiva —entrega de medicamentos, necesidad no satisfecha por razón, oportunidad— reportados con su incertidumbre y su gradiente. Es lo que el artículo 7 de la Ley Estatutaria ya ordena publicar anualmente.

Segundo: reportar siempre el gradiente junto al promedio. Dos de los tres indicadores que mejoraron mantienen brechas socioeconómicas de dos dígitos. Un promedio que mejora sobre una distribución que no se cierra es un resultado distinto de una mejora general, y solo el segundo justifica declarar éxito.

Tercero: la encuesta de hogares es el tercero que el sistema de información no tiene. El debate colombiano sobre el desempeño del sistema se libra hoy entre partes con incentivo financiero directo sobre lo que reportan. La ENCV no compite con el registro administrativo: lo audita, y alcanza a quien el registro no puede ver por construcción —quien necesitó atención y no la buscó, y quien abandonó el tratamiento y por eso dejó de aparecer—. Fortalecer el módulo de salud de la ENCV es, desde ese punto de vista, una inversión en gobernanza y no solo en estadística.

Cuarto: publicar las variables de diseño de todas las rondas. El estrato y el segmento vienen en el microdato de 2022, 2024 y 2025; para 2023 están en un diccionario aparte, entre los materiales relacionados; para el resto de la serie no están. Sin ellas ningún tercero puede reproducir los errores estándar de la serie completa, y sin errores estándar correctos las conclusiones cambian de signo, como muestra el documento DT-03. Es una decisión de transparencia de costo nulo.

· Referencias

- Berwick, D. M., Nolan, T. W., y Whittington, J. (2008). The Triple Aim: Care, health, and cost. *Health Affairs*, 27(3), 759–769.
- Bodenheimer, T., y Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim. *Annals of Family Medicine*, 12(6), 573–576.
- Congreso de Colombia. (1993). *Ley 100 de 1993*, artículos 2 y 153. Bogotá.
- Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1438 de 2011*, artículo 3. Diario Oficial 47.957.
- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículos 6 y 7. Diario Oficial 49.427.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Idler, E. L., y Benyamini, Y. (1997). Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. *Journal of Health and Social Behavior*, 38(1), 21–37.
- Korn, E. L., y Graubard, B. I. (1998). Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. *Survey Methodology*, 24(2), 193–201.
- Lumley, T. (2010). *Complex surveys: A guide to analysis using R*. Hoboken: Wiley.
- Ng, M., Fullman, N., Dieleman, J. L., Flaxman, A. D., Murray, C. J. L., y Lim, S. S. (2014). Effective coverage: a metric for monitoring universal health coverage. *PLoS Medicine*, 11(9), e1001730.
- Nundy, S., Cooper, L. A., y Mate, K. S. (2022). The Quintuple Aim for health care improvement. *JAMA*, 327(6), 521–522.
- Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (2023). *Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report*. Ginebra.
- Radley, D. C., Kolb, K., y Collins, S. R. (2025). *2025 scorecard on state health system performance*. The Commonwealth Fund.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). *Observación General 14* (E/C.12/2000/4), párrs. 12, 43, 47 y 58. Naciones Unidas.
- Corte Constitucional de Colombia, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. (2025, 3 de septiembre). *Auto 1280 de 2025*. M. S. José Fernando Reyes Cuartas.
- Organización Mundial de la Salud. (2025). *Global Health Observatory: UHC service coverage index (SDG 3.8.1)*. Ginebra.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). *Health at a Glance 2025*. París: OCDE.
- Descargo.** Las opiniones, análisis y propuestas de este documento son exclusivamente del autor, a título personal. No comprometen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al Ministerio de Salud y Protección Social, ni a ninguna otra entidad del sector. El trabajo se elabora íntegramente a partir de fuentes de acceso público: microdatos anonimizados del DANE, normatividad publicada, informes oficiales y bases de datos internacionales abiertas. No emplea información reservada, datos personales de beneficiarios ni información de operación contractual. Las propuestas son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.
- Serie «Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo». El código de procesamiento, el catálogo de campos y las verificaciones contra los boletines oficiales son reproducibles. Cualquier error es responsabilidad del autor.